

麻醉下输尿管评估

患者须知 · 修复前精确评估输尿管狭窄

WARWIKI

这是一项在您处于麻醉状态下对输尿管（将尿液从肾脏输送至膀胱的管道）进行的详细检查。医生会综合运用多种检测手段，精确定位狭窄的位置和长度，从而制定最适合的修复方案。

关于这项检查

输尿管狭窄从体外难以准确评估，因此医生会在您处于麻醉状态下直接进行检查。根据实际需要，检查可采用以下方式的**任意组合**：

- **诊断性输尿管镜检查** — 将细软内镜向上伸入输尿管，直接观察内部情况。
- **逆行肾盂造影** — 从膀胱向上注射造影剂，同时拍摄X光片，显示输尿管通道。
- **顺行肾盂造影** — 如果您已有肾脏引流管，造影剂从上方向下注入，从而从两个方向显示狭窄部位。
- **膀胱镜检查／膀胱造影** — 观察膀胱内部并拍摄X光片。

检查目标是绘制精确的"路线图"，包括狭窄的位置、长度和严重程度。如有需要，同次检查还可放置或更换**支架管**或肾脏引流管。

安全吗？

是的，这是一项常见的低风险检查。大多数人术后仅有短暂血尿、轻度排尿烧灼感或腰部隐痛。偶见尿路感染或输尿管短暂刺激；输尿管损伤极为罕见。麻醉通常非常安全。

名词解释

输尿管

将尿液从肾脏输送到膀胱的管道。

狭窄

因瘢痕形成而导致的局部管腔变窄，阻碍尿液流动。

输尿管镜检查

使用细软内镜观察输尿管内部。

逆行肾盂造影

从膀胱向上注射造影剂后拍摄的输尿管及肾盂X光片。

顺行肾盂造影

通过肾脏引流管从上方向下注射造影剂后拍摄的X光片。

肾造瘘管

经后背穿刺引流肾脏的导管；也可经此注射造影剂。

造影剂

在X光片上显示为白色的液体，用于显示管道形态。

支架管

保持输尿管通畅的软性内置管，可在检查时放置或更换。

会疼吗？ 检查期间您处于麻醉状态，不会有任何感觉。术后一两天内可能出现轻度排尿烧灼感、腰部隐痛或淡红色尿液，属正常现象。手术时间较短，通常当天即可回家。

如何准备（检查前）

- 本检查在**麻醉**下进行 — 请严格遵守术前须知（禁食要求及需暂停服用的药物，包括抗凝药）。
- 需进行**尿液检测**以排查感染 — 如有感染须先治愈。
- 保留已有的**肾脏引流管或支架管**，并安排他人接送。

请**提前告知医疗团队**以下情况：

- 曾对**X光造影剂或碘**有过敏反应
- 正在服用**抗凝药**，或有尿路感染症状

检查过程

- 1 在麻醉下入睡，同时给予抗生素预防感染。
- 2 将膀胱镜伸入膀胱，向输尿管内注射造影剂并拍摄X光片，同时或另行将内镜送入输尿管直视观察。
- 3 如您已有肾脏引流管，可从上方注入造影剂，从两个方向显示狭窄部位。
- 4 记录检查结果，如有需要则放置或更换支架管或肾脏引流管。

检查后

- 从麻醉中苏醒后，通常可在**当天回家**，需他人接送。
- 术后一两天内可能出现**轻度烧灼感、腰部隐痛或淡红色尿液**，多饮水有助于缓解。
- 如已放置支架管，出现轻度尿急或排尿不适属正常现象。
- 医生将根据检查结果与您讨论下一步修复方案。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- 腰部或腹部剧烈疼痛或疼痛加重
- 大量出血或尿液中有血块
- 排尿困难，或持续恶心、呕吐

需要记住的三件事

1. 本检查在您处于麻醉状态下，通过内镜和造影剂从上下两个方向精确评估输尿管狭窄，为医生制定修复方案提供依据。
2. 由于需要麻醉，请严格遵守禁食和用药须知，提前治愈感染，保留已有的引流管或支架管，并安排他人接送。
3. 大多数人当天回家。术后一两天内轻度烧灼感、腰部隐痛或尿液略带粉色属正常 — 多饮水，如出现发热、剧烈疼痛或大量出血请及时就医。